HELP_Organi_P03 — Critique — 17 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 3 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

D-013 — Critique — LOT 237 · SSP O7.15

Emplacement : LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.10 › point 11.B › tableau tacrolimus (Envarsus®, Advagraf®, Prograf®)

Contexte : Le cours écrit : posologie d'Envarsus® non lue dans la FI ; la Suisse montre que la conversion vers le tacrolimus 1 fois par jour ne modifie pas la non-adhésion BAASIS.

Question : Quelles doses initiales d'Envarsus® (transplantation rénale et hépatique) donne la FI suisse, et quel facteur de conversion appliquer depuis Prograf® (2 prises) et depuis Advagraf® (1 prise) ? Quel contrôle des taux résiduels après conversion ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-015 — Critique — LOT 237 · SSP O7.15

Emplacement : LOT_237_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › point 9 › tableau « Dosage sérique de l'antiépileptique » ; point 11.B › formes injectables de l'état

de mal

Contexte : Le cours écrit : plages de référence des antiépileptiques non chiffrées ; posologie des formes injectables pour l'état de mal non lue dans la FI.

Question : Quelles doses IV ou IM de première et deuxième ligne pour l'état de mal épileptique (midazolam, lorazépam, lévétiracétam, valproate, phénytoïne/fosphénytoïne) donnent la FI suisse et la recommandation de la Ligue suisse contre l'épilepsie (et l'EAN/ILAE la plus récente) ? Quelles plages thérapeutiques usuelles (lévétiracétam, lamotrigine, valproate, carbamazépine) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-023 — Critique — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.2 › point 11.B › antagonisation de l'AVK (vitamine K) ; A › Bloc 1 › piège PAUSE

Contexte : Le cours écrit : FI adulte de Konakion® MM introuvable (seule la forme pédiatrique lue) ; doses de vitamine K tirées des FI Marcoumar®/Sintrom® ; dose adulte non trouvée.

Question : Quelles doses de Konakion® MM (phytoménadione) chez l'adulte indique la FI suisse, par voie orale et IV, pour un INR élevé sans saignement, avec saignement mineur et avec saignement majeur (associé au concentré de complexe prothrombinique) ? Quel délai d'effet et quel contrôle de l'INR ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-024 — Critique — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc DX.1 et DX.2 › point 11.B › tableau des délais d'arrêt (AOD, HBPM, relais)

Contexte : Le cours cite l'EHRA (figure 14 non lue) et l'ESC 2022 (tableaux non lus) ; délai entre dernière dose curative d'HBPM et chirurgie sans anesthésie neuraxiale non trouvé ; l'audit cite pour Clexane® ≥ 24 h avant un geste neuraxial.

Question : Quel délai sépare la dernière dose curative (et prophylactique) d'énoxaparine (Clexane®) d'une chirurgie sans anesthésie neuraxiale selon la FI suisse, l'ESAIC 2022 (anticoagulation et anesthésie régionale) et l'ESC 2022 ? Quels délais d'arrêt des AOD selon le risque hémorragique et la clairance, d'après le guide EHRA 2021 (figure 14) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-028 — Critique — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.10 › points 8–11 › tableau « Critères cliniques d'anaphylaxie », fenêtre « ② Autres mesures », calendrier « Après la réaction », « Semaines suivantes », fenêtre « Plan pour la prochaine anesthésie », fenêtre « tests cutanés »

Contexte : Le cours cite l'EAACI 2021 en résumé : critères cliniques non transcrits ; durée d'observation, volumes de remplissage, spécialités et doses des antihistaminiques, corticoïdes et salbutamol non trouvés ; délai de consultation allergologique et textes suisses de déclaration non trouvés. L'adrénaline IM est documentée (FI).

Question : Quels critères cliniques d'anaphylaxie, quelles doses d'adrénaline IV titrée en périopératoire (bolus et perfusion, FI suisse et EAACI/SSAPM), quelle conduite pendant la grossesse, quelle durée d'observation après la réaction, quels volumes de remplissage (cristalloïdes, mL/kg) et quelles doses d'antihistaminique, de corticoïde et de salbutamol recommandent l'EAACI 2021 (ou sa mise à jour) et la SSAI (Société suisse d'allergologie et d'immunologie) ? Quel délai pour le bilan allergologique (4 à 6 semaines ?), quelles concentrations des tests cutanés (ENDA/EAACI) et quelle obligation de déclaration à Swissmedic (pharmacovigilance ElViS) s'appliquent ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-073 — Critique — LOT 241 · SSP O7.19

Emplacement : LOT_241_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 (et DX.5 › P2) › point 11.C › surveillance après CAR-T (calendrier biologique, seuils d'arrêt, hématotoxicité, IgG, prophylaxies, revaccination) ; A › fenêtres « calendrier propre à chaque produit » et « tertiaire »

Contexte : Le cours écrit : calendrier biologique détaillé, seuils d'arrêt, critères de gradation de l'hématotoxicité (EHA/EBMT 2023), seuil d'IgG pour la substitution, choix des prophylaxies (aciclovir, cotrimoxazole) et calendrier de revaccination non trouvés (Hayden 2022 non en libre accès).

Question : Que recommandent les consensus EBMT/JACIE/EHA (Hayden 2022 et mise à jour) et EHA/EBMT 2023 (CAR-HEMATOTOX) après une thérapie CAR-T : seuil d'IgG pour la substitution, prophylaxie anti-infectieuse (aciclovir/valaciclovir, cotrimoxazole, antifongique : doses et durée), calendrier de revaccination, calendrier biologique, gradation de l'hématotoxicité ? Quelle position suisse (SBST, centres CAR-T) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-007 — Critique — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre « vasopressine (argipressine, Empressin®) » ; Partie 2 › DX.3 › tableau des traitements du donneur (③ catécholamine, ⑤ hormone thyroïdienne) et calendrier de surveillance

Contexte : Le cours cite Empressin® (indication suisse : choc septique), dopamine 4 µg/kg/min (aucune FI dans AmiKo le 21.10.2026), T4 20 µg puis 10 µg/h ou T3 4 µg puis 3 µg/h (aucune forme i.v. suisse trouvée), desmopressine avec arrêt si Na < 130 mmol/L.

Question : Quel protocole suisse de conditionnement hémodynamique et hormonal du donneur en mort cérébrale est en vigueur (Swiss Donation Pathway, module donneur, Swisstransplant/CNDO, année, URL) : vasopresseur de choix, dose d'argipressine, place de la dopamine et de la noradrénaline, méthylprednisolone, hormone thyroïdienne, desmopressine et fréquence des contrôles de natrémie et diurèse ? Quelles spécialités suisses existent pour la dopamine, la lévothyroxine i.v. et la liothyronine i.v. (ou leur voie d'importation). Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-009 — Critique — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › B2 traitement immunosuppresseur du receveur (tacrolimus, mycophénolate, ciclosporine, évérolimus, bélatacept) ; Partie 4 › DX.9 › évérolimus « mécanisme » (Kaposi)

Contexte : Le cours cite KDIGO 2009 (corticoïdes sans dose) et les FI suisses (Prograf® 0,20–0,30 mg/kg/j, CellCept® 1 g 2×/j, Sandimmun Neoral®, Certican® C0 3–8 ng/mL, Nulojix®) ; durée d'entretien et dose pour le Kaposi absentes.

Question : Quels schémas d'immunosuppression d'induction et d'entretien après greffe rénale suivent les centres suisses (STCS, Swiss Transplant Cohort Study, ou protocoles publiés) et quelle est la recommandation européenne la plus récente (KDIGO 2009 mise à jour ?, ESOT/ERA) : schéma et dose des corticoïdes (bolus puis décroissance), durée de l'entretien, cibles C0 du tacrolimus par période ? Quelle conduite (conversion vers un inhibiteur de mTOR, dose) en cas de sarcome de Kaposi ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-012 — Critique — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › tableau des alternatives (grossesse)

Contexte : Le cours écrit : « Valganciclovir et ganciclovir contre-indiqués ; alternative antivirale : donnée non trouvée ».

Question : Quelle conduite antivirale contre le CMV recommander chez la greffée enceinte, selon l'information professionnelle suisse de Valcyte® et Cymevene® et la recommandation européenne la plus récente : alternative (foscarnet, létermovir, maribavir, immunoglobulines), statut Swissmedic de chacune et surveillance fœtale ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-038 — Critique — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 › tableaux d'interprétation (fonction hépatique sous Marcoumar®, imagerie cérébrale), traitement (adaptation, relais héparine par Liquémine®) et surveillance radiologique

Contexte : Le cours cite l'interruption de Marcoumar® 5–10 jours avant chirurgie, l'héparine dès INR < 2,0 et Liquémine® ; adaptation hépatique/rénale, imagerie de choix et surveillance hépatique absentes.

Question : Quelle conduite suisse ou européenne récente (SSH, EHRA 2021, ESC 2024, guidelines.ch) applique-t-on devant un saignement sous phenprocoumone avec INR élevé : vitamine K (dose, voie), concentré de complexe prothrombinique (Beriplex®, Prothromplex® : dose selon l'INR), imagerie cérébrale de choix ? Quels sont le schéma de relais par héparine et la surveillance hépatique sous Marcoumar® selon la FI suisse ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-041 — Critique — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › tableau thérapeutique (corticostéroïdes 2e intention, furosémide Lasix®), contre-indications de Vi-De 3®, surveillance et pronostic

Contexte : Le cours cite Lasix® 20–40 mg i.v. puis +20 mg toutes les 2 h (FI générale) ; corticoïde sans DCI ni dose ; posologie propre à l'hypercalcémie et critères de guérison absents.

Question : Quel traitement de l'hypercalcémie par intoxication à la vitamine D recommandent une source suisse (Tox Info Suisse, guidelines.ch) ou européenne récente (Society for Endocrinology

2016, ESE) : hydratation (volume), diurétique de l'anse (place et dose), glucocorticoïde (DCI, dose, durée), bisphosphonate (zolédronate, pamidronate : dose et adaptation rénale), calcitonine, dialyse ; calendrier de surveillance de la calcémie et de la calciurie ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-046 — Critique — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › tableau des examens (dissection cervicale) ; Partie 4 › DX.9 › tableau thérapeutique (3. antiplaquettaire : Aspirine® Cardio)

Contexte : Le cours écrit pour Aspirine® Cardio : « indication suisse de prévention après accident ischémique transitoire : 100 mg 3 fois par jour ou 300 mg 1 fois par jour » et cite l'essai TREAT-CAD ; aucune méthode d'imagerie ne détecte tous les cas.

Question : Vérifier dans la FI suisse d'Aspirine® Cardio (date de révision) la posologie exacte après AIT ou AVC (le schéma « 100 mg 3 fois par jour » paraît erroné) et les contre-indications rénales et hépatiques. Quel traitement antithrombotique (antiplaquettaire ou anticoagulant, durée) et quelle imagerie de première intention (IRM avec séquences T1 fat-sat, angio-TC, échographie) recommandent la Société suisse neurovasculaire / Swiss Stroke Society ou l'ESO (guideline la plus récente sur la dissection cervicale) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-051 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › fenêtre 4.1 Bio-Mathématique (ClCr 30–50 ml/min) ; Bloc 2 › tableau « exemples avec les anticoagulants » (édoxaban, rivaroxaban) ; tableau INR phenprocoumone

Contexte : Le cours donne dabigatran 110 mg 2×/j avec amiodarone ou vérapamil, édoxaban 30 mg 1×/j avec ciclosporine, dronédarone, érythromycine, kétoconazole, quinidine, vérapamil, rivaroxaban non recommandé avec azolés et ritonavir ; INR > 3,5 demi-comprimé, > 4,5 ne pas donner ; cible INR absente.

Question : Selon les FI suisses en vigueur de Pradaxa®, Lixiana®, Xarelto®, Eliquis® et Marcoumar® (date de révision), quelles réductions de dose s'appliquent selon la clairance de la créatinine (Cockcroft-Gault), le poids et les inhibiteurs de la P-gp ou du CYP3A4 (amiodarone, vérapamil, dronédarone, ciclosporine, macrolides, azolés, ritonavir) ? Quelle cible d'INR et quel schéma de correction d'un INR élevé sans saignement (vitamine K per os, dose) recommandent la

SSH ou l'ESC 2024 ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-052 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › tableau « adaptations selon le terrain » (grossesse, allergie au contraste) et durée de l'adrénaline ; Partie 2 › DX.4 › fenêtre 6.1 (tryptase de base), adrénaline intramusculaire, glucagon et bêtabloquants, surveillance

Contexte : Le cours suit WAO 2020 (adrénaline 0,01 mg/kg i.m., maximum 0,5 mg, toutes les 5–15 min ; observation des réactions biphasiques 6–12 h) ; tryptase de base, adaptations en grossesse et insuffisance rénale absentes.

Question : Quelle recommandation suisse en vigueur (SSAI/SGAI, guidelines.ch) ou européenne la plus récente (EAACI 2021, WAO 2020 mise à jour) encadre le traitement de l'anaphylaxie médicamenteuse : adrénaline i.m. (dose selon l'âge et le poids, auto-injecteurs suisses Jext®, EpiPen®, Emerade® et dosages), glucagon sous bêtabloquant, durée d'observation, femme enceinte ? Quel seuil de tryptase (formule 20 % + 2 ng/ml, tryptase de base) confirme la réaction ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-053 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 › fenêtre 11.1 « Moyens pharmacologiques » (cholestyramine, antidotes), surveillance et pronostic

Contexte : Le cours cite cholestyramine 5 × 4 g/j « non vérifiée dans le dossier », Praxbind® 5 g, Ondexxya™ 400 mg puis 4 mg/min, Beriplex® 25 UI/kg pour INR 2,0–3,9 ; adaptation rénale ou hépatique, surveillance radiologique et critère de guérison absents.

Question : Selon les FI suisses et la liste suisse des antidotes (Tox Info Suisse/Société suisse de pharmacologie et toxicologie cliniques, édition la plus récente), quelles sont l'indication, la dose et la disponibilité de la cholestyramine (Quantalan®) pour accélérer l'élimination de la phenprocoumone, de l'idarucizumab, de l'andexanet alfa et du concentré de complexe prothrombinique dans l'hémorragie sous anticoagulant ? Quelle surveillance (ECG, imagerie de contrôle en cas d'hémorragie intracrânienne) recommande l'ESO ou l'ESC ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de

révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-054 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 › triple whammy et hyperkaliémie (symptômes extra-cardiaques, grossesse et enfant, pronostic)

Contexte : Le cours dit qu'un K+ ≥ 6,5 mmol/l en ville impose une évaluation hospitalière immédiate ; traitement chez la femme enceinte et l'enfant, adaptation hépatique et symptômes extra-cardiaques absents.

Question : Quelle recommandation suisse ou européenne la plus récente (ERC 2025, KDIGO 2020 controverses sur le potassium, UK Kidney Association 2023 en comparaison) encadre le traitement aigu de l'hyperkaliémie : seuils d'urgence, gluconate de calcium, insuline-glucose (doses), salbutamol, chélateurs (patiromère Veltassa®, cyclosilicate de zirconium Lokelma® : statut et dose suisse), adaptations chez l'enfant et la femme enceinte ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-055 — Critique — LOT 244 · SSP O7.22

Emplacement : LOT_244_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 › intoxication digitalique (hausse sous clarithromycine, gold standard, électrolytes et fonction rénale, DigiFab®, atropine, pronostic)

Contexte : Le cours cite DigiFab® 40 mg/flacon (Curatis AG) et l'atropine Sintetica (adulte 0,5–1,0 mg, enfant 0,1–0,4 mg selon le poids) ; ampleur de la hausse sous clarithromycine, seuil de calcium, conduite rénale et atropine en grossesse et insuffisance rénale absents.

Question : Selon la FI suisse de DigiFab® et la liste suisse des antidotes, quelles indications (digoxinémie, kaliémie, troubles du rythme) et quelle dose (calcul selon la digoxinémie ou la quantité ingérée, dose empirique aiguë et chronique) s'appliquent ? Quelle digoxinémie thérapeutique et toxique retenir, quelle hausse attendre sous clarithromycine, quel ajustement selon la fonction rénale, et quelles précautions de l'atropine en grossesse et insuffisance rénale ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P03 — 17 questions : D-013, D-015, D-023, D-024, D-028, D-073, E-007, E-009, E-012, E-038, E-041, E-046, E-051, E-052, E-053, E-054, E-055